PLANO DE ANÚNCIOS PARA CONSULTÓRIO · VERSÃO DE 04/11/2026

Como eu faria seus anúncios de Ginecologia

Plano para quem tem consultório próprio, continuando o carrossel: a conta, a verba, as campanhas, os criativos e o combinado com a recepção, para ginecologia.

1 A conta da consulta, antes de qualquer anúncio

Clínica não compra conversa. Clínica compra paciente sentado na cadeira. Por isso a primeira coisa que eu faria é esta conta, com os seus números.

1 O valor da consulta que você cobra

2 menos o que ela custa para você (equipe, aluguel, imposto) = o que sobra

3 Valor da consulta ÷ o que sobra = quanto cada R$ 1 de anúncio precisa voltar para empatar

EXEMPLO, NÃO É NÚMERO SEU

Consulta de R$ 400, sobram R$ 200	**cada R$ 1 precisa voltar R$ 2**
Com 25% de desconto: consulta de R$ 300, sobram R$ 100	**cada R$ 1 precisa voltar R$ 3**
R$ 1.000 de verba a R$ 10 por conversa = 100 conversas	**16 consultas realizadas, R$ 6.400 em consultas de R$ 400 (se 40% agendam e 40% comparecem)**

Seus números: consulta R$ _____ · sobra R$ _____ · cada R$ 1 precisa voltar R$ _____

Os 40% são benchmark de mercado (funil 40/40/40, do método de Pedro Sobral): de 100 conversas, 40 agendam, 16 comparecem e 4 fecham tratamento ou procedimento. Serve só para abrir a conversa. Com 60 a 90 dias de campanha, vale o número da sua conta, e só ele.

O que entra na conta nesta especialidade

Ginecologia mistura consulta de rotina, que a paciente repete, e consulta por queixa. Se você faz pré-natal ou acompanha gestação, o valor ao longo dos meses entra na conta. Se não faz, não conte.

2 Onde colocar a verba

Google
vai quem tem urgência. O paciente já está procurando e escolhe quem aparece e responde primeiro.

Meta (Instagram e Facebook)
vai quem tem ticket e precisa de confiança. Antes de vender o preço, eu preciso vender o médico.

Notoriedade
médico já conhecido na cidade rende no Google mesmo com ticket alto.

COMBO: DIVISÃO PARECIDA

Queixa que incomoda, como corrimento, dor, atraso ou cólica forte, vira busca no Google na hora. Já a consulta de rotina vive de confiança: a paciente escolhe a médica pela forma como ela explica. O Google segura a queixa. A Meta segura a escolha da médica, com vídeo de quem explica sem julgar.

A fatia exata de cada lado eu só fecho com 60 a 90 dias de dado da sua conta. Aqui está o ponto de partida.

3 As 3 campanhas do Google

Volume de busca e custo por clique eu não medi para a sua cidade. Tudo abaixo é para testar, não é dado. Eu começaria em correspondência exata, e abriria para frase só se a exata não gastar a verba.

1. Nome do médico

Quem já ouviu falar de você e vai conferir. Teto de R$ 30 por dia.

- dr. / dra. [seu nome]
- [seu nome] [cidade]
- [nome da clínica] [cidade]

2. Especialidade + cidade

Quem já sabe qual médico procura e está comparando.

- ginecologista [cidade]
- ginecologista particular [cidade]
- consulta ginecológica [cidade]
- preventivo [cidade]
- ginecologista mulher [cidade]
- ginecologista perto de mim

3. Sintoma

Quem ainda não sabe qual médico resolve. Ele pesquisa o que sente.

- corrimento com cheiro
- dor na relação
- cólica muito forte
- menstruação atrasada
- menstruação irregular
- sangramento fora do período
- coceira íntima

Negativar de saída: "chá para menstruar", "remédio caseiro", "teste de farmácia", "grátis", "SUS", "aborto".

> Pré-natal e gestante com queixa precisam de caminho claro para urgência. O anúncio de sintoma não deve prometer consulta no mesmo dia se você não consegue cumprir.

Destino do clique: o WhatsApp da recepção ou uma página curta com preço, forma de pagamento e endereço. O clique no botão de WhatsApp é a conversão que eu marco.

4 Público e sequência na Meta

Público

Mulheres adultas da cidade e do raio. O criativo fala de uma situação só: o preventivo atrasado, a cólica que atrapalha o dia ou a primeira consulta de uma filha. Mãe de adolescente é um público à parte, com vídeo próprio.

MÊS 1

70% no topo

70% da verba vai para quem ainda não conhece o seu nome, com vídeo que tira dúvida. Os 30% restantes vão para o anúncio de consulta, com preço e forma de pagamento, para quem já viu o vídeo.

Os dois primeiros vídeos do mês mostram como é a consulta passo a passo e respondem se doer no preventivo é normal.

MÊS 2 EM DIANTE

60% em remarketing

60% da verba vai para quem já conhece você: quem chamou no WhatsApp (180 dias), quem visitou o site (90 dias) e quem assistiu aos vídeos (30 dias). O topo continua rodando com o resto.

Quem chamou e não marcou vê um vídeo curto sobre o que perguntar na consulta. Quem assistiu ao vídeo do preventivo vê o anúncio de consulta com valor e horários.

Eu não mexo numa campanha em menos de 72 horas e olho o mês, não o dia. Eu reporto duas medidas lado a lado: conversa iniciada e segunda mensagem enviada. Só a primeira infla.

5 3 ângulos de criativo

Cada um filtra um paciente. Atenção sem filtro traz curioso, e curioso encarece a conversa.

Faz quanto tempo?

"Faz mais de um ano do seu último preventivo? Eu explico a consulta passo a passo."

Vídeo da médica. Filtra a paciente que adia por receio, e reduz o medo do desconhecido.

Cólica que atrapalha o dia

"Cólica que faz você faltar ao trabalho merece uma consulta, não só um remédio."

Reel ou carrossel. Filtra quem já se acostumou a aguentar calada.

Primeira vez no ginecologista

"Primeira consulta no ginecologista: o que acontece, o que não precisa levar e o que você pode perguntar."

Carrossel pensado também para a mãe que vai marcar para a filha.

6 5 dúvidas de paciente para virar conteúdo

1. "Dor no preventivo é normal?"
2. "Posso ir ao ginecologista menstruada?"
3. "Todo corrimento é infecção?"
4. "Com que idade a menina deve ir pela primeira vez?"
5. "Quanto tempo posso ficar sem fazer preventivo?"

Cada dúvida vira um vídeo ou carrossel. Toda resposta com número ou critério precisa de fonte que você possa citar. Sem fonte, tira o número e fica o raciocínio.

7 O combinado com a recepção

Eu trabalho com 20 minutos como limite de resposta: quem tem dor costuma chamar mais de um consultório e fecha com quem responde primeiro e já oferece horário.

Quem responde | **Em quanto tempo** | **O que a IA pode fazer sozinha**

A primeira resposta, por escrito

Repetir o que a pessoa pediu, informar o valor e oferecer dois dias e horários. Cadastro e reserva vêm depois da escolha.

Pergunta inicial: "É consulta de rotina ou você está com algum incômodo agora?"

Urgência e encaixe

Sangramento intenso, dor forte ou gestante com queixa: a recepção não marca para a semana que vem. Passa para a médica ou orienta pronto atendimento, conforme o que você definir.

Parte das pacientes evita contar a queixa por mensagem. A recepção não pede detalhe: oferece dois horários e, se ela preferir, uma ligação.

Automático pode ser o aviso de recebimento, a pergunta inicial e o lembrete de horário. Preço, horário e qualquer orientação de saúde saem de uma pessoa ou de um texto que você já aprovou.

8 O que eu NÃO faria, pelo conselho

Base: Resolução CFM 2.336/2023, a vigente. Ela permite informar preço, forma de pagamento e desconto. Continua fora:

- Promessa de resultado, em qualquer forma.
- Antes e depois.
- Nota, estrela ou print de avaliação.
- Chamar alguém de especialista sem o RQE registrado.
- Escassez que não existe. "Últimos horários" só se a agenda estiver fechando de verdade.

Nesta especialidade, o risco mais comum

- Foto de corpo ou antes e depois de procedimento íntimo ou estético.
- Promessa de fertilidade, de engravidar ou de resolver a queixa.
- Texto de medo, como "o seu corpo está te avisando".
- Colocar "ginecologista" ou "obstetra" no título sem o RQE. Sem ele, use "médica" e a área em que atende.

Antes de subir qualquer anúncio, o texto passa por revisão. Este plano não substitui a leitura da resolução pelo responsável técnico.

E antes da conversa chegar?

O plano cuida do anúncio e da recepção. O Raio-X olha o passo anterior: como o seu consultório aparece hoje no Google e na IA. Leva poucos minutos.

Fazer o Raio-X do meu consultório